



FICHA ÚNICA DE ANAMNESIS – PSICOEDUKA

Instrucciones para la familia

Estimado/a tutor/a – apoderado/a – cuidador/a:

La siguiente anamnesis tiene como objetivo recopilar información relevante sobre la historia del niño/a, su desarrollo, contexto familiar, escolar y de salud, con el fin de iniciar un proceso de evaluación e intervención integral en Psicoeduka.

Por favor, responda con la mayor sinceridad posible, considerando que no existen respuestas correctas o incorrectas, sino información necesaria para comprender su realidad.

I. DATOS DE QUIEN RESPONDE

- Nombre completo: Carolina Valeska Tello Cabello y Javier Andrés Jeria Magaña.
- Relación con el niño/a: madre y padre.
- Teléfono principal: 957181668 (teléfono madre) 957181654 (teléfono padre).
- Correo electrónico: carov.telloc@gmail.com y javojeria@gmail.com
- Región / Comuna: Región Metropolitana, Las Condes.

Nombre del profesional que entrevista: Fernanda Álvarez von Knorring

Fecha de entrevista: 16 de abril del 2026

II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL NIÑO/A

- Nombre completo: Bruno Jeria Tello
- RUT: 24.223.795-1
- Fecha de nacimiento: 16/03/2013
- Edad: 13 años, 1 mes, 5 días
- Sexo: ☐ Femenino ☒ Masculino ☐ Otro
- Previsión de salud: Isapre
- Dirección: Olga Norte 1317, departamento 302
- Región / Comuna: Región Metropolitana, Las Condes.

III. MOTIVO DE CONSULTA

1. ¿Cuál es el principal motivo por el que consulta en Psicoeduka?

“Hace tiempo necesitábamos venir, pero ahora sucedió algo hacer un par de meses, mi hermana tiene una hija de 7 años y mi hermana me comenta que mi sobrina le dijo a ella que Bruno le había tocado ciertas partes íntimas... él dice que no, que solo la levantó para jugar. Por eso lo estuvimos observando por un tiempo, pero bajamos la guardia y luego mi hermana me dijo que se supone que le tocó la vagina a mi sobrina mientras la tomaba para girarla, no pensó que la estaba tocando, por eso estaríamos atentos (menciona la madre).

“Empezamos a averiguar y encontramos pornografía en su celular que para mí no es normal, no era pornografía de un hombre con una mujer, eran animaciones de humanos con animales, además se creó un correo falso donde busca estas cosas. Él nos preguntó si estábamos enojados, nosotros dijimos que no, pero para nosotros no es normal eso, no se le ve muy interesado en las niñas, a veces le preguntamos, pero dice como “quizás soy gay” sin saber nosotros que piensa realmente” (menciona la madre).

2. ¿Desde cuándo comenzaron las dificultades?

Hace un par de meses atrás cuando mi hermana me habla, además, él tiene colitis ulcerosa entonces pasaba mucho tiempo en el baño, ahora no sabemos si era por eso por lo que iba mucho o veía cosas en el celular porque siempre en la casa tiene su puerta sin pestillo, no dejamos que la cierre y ya no lo dejamos ir al baño con el celular. Ahora también, agregamos el nuevo correo al grupo de familia para poder supervisarlo, pero puede que tenga otro correo, no sabemos bien porque vimos una conversación donde salía algo así. Solo tiene el correo del colegio, el de Bruno y el que creó con el nombre falso. Hace dos semanas aproximadamente mi hermana me vuelve a hablar por esta situación. Nosotros no sabemos si en el contexto del colegio con sus compañeras pasa esto, nosotros sabemos igual que tiene más confianza con su prima y también con su primo que es TEA entonces juegan más brusco.

3. ¿A qué atribuyen ustedes estas dificultades?

Creemos que es parte de la adolescencia revisar contenido pornográfico, nosotros podemos hablar de estos temas, pero sé que hay cosa que también oculta y que no lo diría. Sé que es normal que busquen su manera de ver la sexualidad, pero tampoco sabemos si estas cosas se las dijeron otros compañeros o alguien más. Según él, le apareció una foto en alguna parte en el computador y como le llamó la atención lo buscó en otro lado. Hablando con mi hermana, ella me dice que quizás en algún momento él pudo haber sido tocado o algo así, pero yo hablé con él y me dice que no (menciona la madre).

La segunda vez que pasa esto, mi sobrina le dice algo al oído a mi hermana y salen de la casa para conversar, pero también ella quería jugar con ellos. Entre medio de estos dos momentos hubo un paseo familiar donde estaban en la piscina y mi sobrina le dice a su mamá que él la había tocado, pero mi hermana no le dio mayor importancia porque estaban en la piscina y pudieron toparse.

4. ¿Qué tratamientos, apoyos o intervenciones ha recibido anteriormente?

Estuvo con psicólogo como a los 5 años durante unos 6 meses, más que nada porque el colegio lo derivó por su comportamiento. En Psicoeduka estuvo con terapeuta ocupacional unos dos años aproximadamente hasta antes de la pandemia, también estuvo con psiquiatra para la dosis del medicamento metilfenidato que actualmente son 27 mg en la mañana, a ella la ven actualmente una vez al año para control de dosis de medicamento.

A los 5 años fue diagnosticado con TDAH, pero en un principio la psiquiatra sospechaba como diagnóstico que podría ser opositor desafiante, más que nada por su comportamiento en el primer colegio, pero con los años se descartó. También hubo sospechas de TEA, pero nunca se hicieron pruebas, solo se descartaron las demás por el diagnóstico de TDAH.

IV. EXPECTATIVAS FAMILIARES

- ¿Cuáles son sus expectativas respecto del proceso de evaluación e intervención en Psicoeduka?

Saber si esto está pasando realmente, es lo que más nos importa, actuar frente a eso antes de que pueda pasar a algo más grave (situación con la prima y tema de la pornografía en el celular). También regular su conducta o quizás tener nosotros como padres las herramientas para poder guiarlo de mejor manera. Sabemos que estos son temas que ven los papás, pero quizás una mirada externa profesional también podría servir para tener más información.

V. ANTECEDENTES FAMILIARES

Composición familiar

- ¿Con quién vive actualmente el niño/a?

Con la madre y el padre.

Madre / figura materna

- Nombre: Carolina Valeska Tello Cabello.
- Edad: 43 años.
- Ocupación: técnico en enfermería.
- Nivel educacional: universitario incompleto.
- Relación con el niño/a: madre.

Padre / figura paterna

- Nombre: Javier Andrés Jeria Magaña.
- Edad: 48 años.
- Ocupación: administrativo.
- Nivel educacional: técnico.
- Relación con el niño/a: padre.

VI. ANTECEDENTES PERINATALES

Embarazo

- ¿Cómo fue la reacción emocional ante el embarazo?

Buena, sorprendidos, pero bien.

- ¿Fue un embarazo planificado? ☐ Sí ☒ No
- ¿Cómo fue la salud de la madre durante la gestación?

Fue cuando más me cuidé, me dieron metformina por la resistencia a la insulina y una dieta baja en carbohidratos, prácticamente solo subí los kilos del bebé.

Parto

- Edad gestacional al nacimiento: 39 semanas.
- Tipo de parto: cesárea programada.
- ¿Hubo complicaciones? ¿Cuáles?

Bruno venía con el cordón corto, no bajó nunca asique tuvieron que sacarlo por cesárea y programarlo todo, si no lo sacaban se hubiese ahogado.

- Apgar: 10.
-

VII. ANTECEDENTES MÉDICOS Y DE SALUD

- Diagnósticos previos: Asma, actualmente sin tratamiento, estuvo hospitalizado por neumonía y en el hospital se contagió de adenovirus a los 5 meses y medio, estando 13 días hospitalizado con oxígeno y antibióticos. Posteriormente, tuvo repetidamente neumonía y bronquitis, pero desde los 7 años ya se resfría solo de forma leve.
- Medicamentos actuales (nombre y dosis): Metilfenidato 27 mg y Mesalazina 3 gr, ambos una vez al día.
- Alergias conocidas: Azitromicina, picaduras de abeja (enrojecimiento en la zona).
- Cirugías u hospitalizaciones: fimosis a los 4 años y a la edad de 1 año y medio sufre una quemadura con agua hirviendo en el brazo por lo que entra a pabellón a aseo quirúrgico por mal olor de la herida (actualmente tiene una cicatriz).
- Enfermedades familiares relevantes (mentales o crónicas): Por el lado paterno, tanto el abuelo, el padrino y la abuela fueron diagnosticados con cáncer de pulmón. Papá es asmático de pequeño, pero actualmente está controlado.

Desde el lado materno, madre tiene diagnóstico de depresión con medicamentos, abuela y abuelo son hipertensos. Madre usa salbutamol cuando se sobre exige en ejercicios de alto impacto.

VIII. DESARROLLO PSICOMOTOR Y FUNCIONAL

Alimentación y lactancia

- Tipo de lactancia: ☐ Materna ☐ Artificial ☒ Mixta
- ¿Cómo fue el proceso de alimentación y destete?

No fue pensado ni programado, solo se tuvo que realizar ya que cayó hospitalizado y por temas de seguridad era importante darle en mamadera para no salir de incubadora.

Lenguaje y comunicación

- Edad inicio contacto ocular: 3-4 meses aproximadamente.
- Edad inicio balbuceo: 3-4 meses aproximadamente.
- Edad primera palabra: 6 meses.
- Edad primera frase: Desconocen
- ¿Localiza sonidos? ☒ Sí ☐ No
- ¿Imita sonidos? ☒ Sí ☐ No
- ¿Interactúa con otros niños? Ejemplo: De pequeño si, desde su primer año, luego en el curso de kínder o primero básico aproximadamente podía ser amigo de todos, pero yo (madre) igual siento que le dije muchas cosas que lo asustaron y ya no quería hablar con nadie, le costaba hacer amigos, hasta hoy en día. Se relaciona con el resto, tiene su grupo personal, pero hay 3 o 4 niños con los que no habla, no hay relación.

Uso de pantallas

- ¿Ve pantallas? ☒ Sí ☐ No
- Tipo de contenido / tiempo / supervisión:

Videojuegos de computador, videos de comedia y series de animación japonesa. Puede estar muchas horas del día conectado, si no se le supervisa puede permanecer las 12 horas del día sin desconectarse. Intentamos ponerle horarios de supervisión durante el día, pero no cumple con aquello.

Motricidad – marcha

- Edad en que se sentó solo/a: desconocen.
- Primeros pasos: a los 8 meses.
- ¿Hubo accidentes? ☒ Sí ☐ No
- Reacción ante este cambio:

A los 6 meses de edad se cayó del sillón, pero no hubo mayor complicación, además sufrió de una quemadura con agua hirviendo lo cual le dejó una cicatriz. Para nosotros como padres fue estresante que empezara a caminar ya que teníamos menos control, debíamos cubrir los lugares y adaptar la casa.

Sueño

- ¿Con quién durmió los primeros meses? Con ambos.
- ¿Presenta dificultades para dormir? Si, cuando está sobre estimulado con las pantallas le cuesta conciliar el sueño, se despierta en las noches y algunas veces es sonámbulos.
- ¿Necesita rituales o compañía para dormir?

Hace 5 años que duerme en la misma cama con la madre, el padre duerme en la pieza de Bruno. Hace 2 años aproximadamente sufrieron un accidente de auto, donde posterior a ello Bruno comenzó a dormir acompañado, luego más adelante retomó el dormir solo, pero volvieron a tener un accidente vehicular. Sólo logra conciliar el sueño si la madre está presente con él en la habitación.

Control de esfínter

- Edad de inicio: desconoce, pero a los 10 años aproximadamente.
- Forma en que lo aprendió: sin consumo de líquidos antes de dormir. Aprendió a avisar en periodo de uso de pañal.

IX. ÁMBITO ESCOLAR

Jardín infantil / Sala cuna

- ¿Asistió? ☒ Sí ☐ No
- Edad de ingreso: 5 meses y medio.
- Motivo de ingreso: no tenían quien pudiese cuidarlo.
- Adaptación y relación con pares: se adaptó bien, sin complicaciones.

Escolaridad actual

- Nombre del establecimiento: Santa María de las Condes.
- Nivel / curso: 8° básico
- Jornada: ☐ Mañana ☐ Tarde ☒ Completa
- Horas diarias: tres días a la semana de 08:00 am a 16:00 pm y los otros dos días de 08:00 am a 14:00 pm.
- ¿Presenta adecuaciones curriculares? ☐ Sí ☒ No

Trayectoria escolar

- Establecimientos anteriores y motivo de cambio:
 1. Nuestra Señora del Rosario, cambio por mala relación con profesora.
 2. Colegio San Jorge, cambio porque la familia buscaba una alternativa de mejor calidad.
 3. Santa María de las Condes.

- ¿Repitencias? ☐ Sí ☒ No
- Apoyos o intervenciones previas (PIE, tutorías, etc.):

En el establecimiento Santa María de las Condes estuvo en el programa PIE.

- Relación con docentes: No tiene malas relaciones, actualmente buena relación con su profesor actual pese a que algunos profesores no le gustan.
- Relación con pares: buena, con algunos compañeros no habla.
- Desempeño académico general: bien, promedio 6.0.

X. REDES DE APOYO Y PROFESIONALES EXTERNOS

- Médicos o especialistas tratantes (nombre y especialidad):

Jorge Saba (gastroenterólogo) y Adriana Collao (psiquiatra).

- Terapias actuales o previas:

-Tratamiento con psicólogo a los 5 años.

-Tratamiento con psiquiatra una vez al año para control de dosis de medicamento.

-En Psicoeduka estuvo con terapeuta ocupacional unos dos años aproximadamente hasta antes de la pandemia.

XI. REGULACIÓN, INTERESES Y OBSERVACIONES

- Juegos o elementos preferidos: bicicleta, voleibol, basquetbol, juegos de computador, celular.
- Actividades favoritas: jugar en el computador.
- Cosas que lo/la tranquilizan: su mascota (gato).
- Desencadenantes o sensibilidades: cuando le cambian el tono de voz al hablar, reglas y normas, sobre todo si es el padre quien se las dice.
- Otras observaciones relevantes: no.

¡Muchísimas gracias!